

«Інфекційний мононуклеоз»

1. Завдання, що виконуються здобувачем освіти на станції:

- Продемонструвати навичку «Перкусія печінки за Курловим».
- Оцінити клінічний аналіз крові.
- Оцінити результат дослідження сироватки крові методом ІФА на наявність анти-VCA-IgM.
- Оцінити результат дослідження сироватки крові на ДНК вірусу Епштейн -Бар (ЕБВ) методом ПЛР.
- Встановити попередній діагноз.
- Визначити тактику ведення та лікування.
- Означити рекомендації щодо профілактики та пропаганди здорового способу життя.

2. Клінічні кейси (сценарії, задачі), які відпрацьовуються на станції з пакетами додаткових матеріалів:

- Сценарій «Діагностика та подальша тактика ведення і лікування хворого з діагнозом інфекційний мононуклеоз».

Ви лікар приймального відділення. До Вас звернувся Ви – хлопець 17 років, студент.

Скарги: на гарячку до 39°C, болі в горлі, слабкість, закладеність носа.

Анамнез захворювання: хворіє протягом тижня, спочатку підвищилась температура до 38°C, потім з'явилися болі при ковтанні. Було діагностовано гострий тонзиліт, призначений еритроміцин. Ефекту від терапії не було. Зберігалася висока температура, накладання на мигдаликах, з'явилася припухлість в області шиї з обох сторін, закладеність носу. Госпіталізовано з діагнозом: підозра на дифтерію ротоглотки.

Анамнез життя: туберкульоз та гепатити заперечує. Хворів ГРВІ, у дитинстві ангіною. Операцій та травм не було. Алергічних реакцій немає.

Об'єктивно: при надходженні стан середньо тяжкий, температура 39°C, обличчя одутле, носом не дихає, голос із гугнявим відтінком, склери субіктеричні. В області шиї з обох боків, більше ліворуч, видно на око збільшені задньошийні та передньошийні лімфовузли, з деякою набряклістю навколо них. Під час пальпації передньошийні, задньошийні та пахвові лімфовузли збільшені 2 см в діаметрі з обох боків, щільно еластичні й помірно болючі. Розміри інших лімфовузлів до 3-4 см.

У ротоглотці – яскрава гіперемія, на збільшених піднебінних мигдаликах суцільні накладання біло-жовтого кольору. Язик густо обкладений білим нальотом. Дихання везикулярне. ЧД - 18 за хв. Тахікардія 100 за хв. Живіт м'який, безболісний. Печінка та селезінка виступають з-під краю реберної дуги на + 3 см.

- Додаток 1. Клінічний аналіз крові.

Показник, що досліджується	Показник хворого	Норма	
		Чоловіки	Жінки
Еритроцити	3,5 x10 ¹² /л	4,0-5,1x10 ¹² /л	3,7-4,7x10 ¹² /л
Гемоглобін	147 г/л	130-160 г/л	120-140 г/л
Колірний показник	0,9	0,86-1,05	

Гематокрит	40 %	38-49 %	33-45 %
Тромбоцити	225 x10 ⁹ /л	180-320x10 ⁹ /л	
Кількість лейкоцитів	15,2 x10 ⁹ /л	4,0-8,8x10 ⁹ /л	
Лейкоцитарна формула:			
- мієлоцити	0	відсутні	
- метамієлоцити	0	відсутні	
- нейтрофіли:			
паличкоядерні	1 %	0,04-0,300x10 ⁹ /л (1-6 %)	
сегментоядерні	11 %	2,0-5,5x10 ⁹ /л (45-70 %)	
- еозинофіли	0 %	0,02-0,3x10 ⁹ /л (0-5 %)	
- базофіли	0	0-0,065x10 ⁹ /л (0-1 %)	
- лімфоцити	71 %	1,2-3,0x10 ⁹ /л (18-40 %)	
- моноцити	4 %	0,09-0,6x10 ⁹ /л (2-9 %)	
плазматичні клітки	0	відсутні	
ШОЕ, мм/год	25 мм/год	1-10	2-15

- Додаток 2. Результат дослідження сироватки крові методом ПЛР на наявність анти-VCA-IgM.

Показник, що досліджується	Показник хворого	Норма
ДНК ЕБВ	позитивний	відсутній

- Додаток 3 Результат дослідження сироватки крові на ДНК вірусу Епіштейн -Бар (ЕБВ) методом ИФА.

Показник, що досліджується	Показник хворого	Норма
анти-VCA-IgM	14.5	0-0,9

3. Інформація для студента – алгоритм роботи на станції.

Ви зібрали скарги, анамнез захворювання та життя, провели об'єктивне обстеження:

Алгоритм дій здобувача.

	Дії здобувача освіти	Форма представлення
1.ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ):		
	інформовану згоду отримано;	Сказати
	обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні.	Виконати
2.ВИКОНАННЯ НАВИЧКИ «ПЕРКУСІЯ ПЕЧІНКИ ЗА КУРЛОВИМ»:		

	Перший розмір. Верхня межа: коректна перкусія по правій середньо-ключичній лінії, визначити точки переходу ясного легеневого	
--	--	--

	звука в тупий печінковий	Виконати
	Нижня межа: коректна перкусія по правій срединно-ключичній лінії від пупка вгору до визначення точки переходу тимпанічного звука в тупий. Поєднавши дві точки, виміряти перший розмір печінки за методом Курлова.	
	Другий розмір. За верхню межу цього розміру умовно приймають точку, що лежить на одному рівні з верхньою межею першого розміру печінкової тупості (через цю точку проводять горизонталь до перетину з срединною лінією)	
	Нижня межа: коректна перкусія по срединній лінії живота до появи печінкової тупості. З'єднавши ці точки, вимірюють другий розмір печінки за методом Курлова.	Виконати
	Третій розмір. Верхня межа відповідає верхній точці другого розміру печінки. Нижня межа: коректна перкусія по лівій реберній дузі, починаючи перкусію приблизно з передньої пахвової лінії. З'єднавши ці точки, вимірюють третій розмір печінки за методом Курлова.	
	Розміри печінки по Курлову	Сказати
	Самопочуття пацієнта задовільне	Сказати
3. ДІАГНОСТИКА:		
Оцінити клінічний аналіз крові. (Додаток 1)	Лейкоцитоз за рахунок лімфоцитів (71%), зсув лейкоцитарної формули вправо, прискорена ШОЕ - ознаки вірусної інфекції: Наявність атипових мононуклеарів свідчить про наявність у хворого інфекційного мононуклеозу.	Сказати/записати в історію хвороби

Оцінити результат дослідження сироватки крові методом ІФА на наявність анти-VCA-IgM	Наявність анти-VCA-IgM у великій кількості свідчить про реплікацію вірусу..	Сказати/записати в історію хвороби
---	---	------------------------------------

(Додаток 2)		
Оцінити результат дослідження сироватки крові на ДНК вірусу Епштейн -Бар (ЕБВ) методом ПЛР (Додаток 3)	Позитивний результат дослідження на виявлення ДНК вірусу Епштейн -Бар в сироватці крові свідчить про наявність у хворого інфекційного мононуклеозу.	Сказати/записати в історію хвороби
<i>Встановити попередній діагноз:</i>	Інфекційний мононуклеоз, спричинений вірусом Епштейн -Бар	Сказати/записати в історію хвороби
4.ВИЗНАЧЕННЯ ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ		
<i>Призначено наступні ліки:</i>	Госпіталізація для подальшого обстеження та підбору оптимальної терапії. Спокій, ліжковий режим. Нестероїдні протизапальні препарати, Глюкокортикостероїди При антибіотиках возможна токсидермия.	Сказати/записати в історію хвороби
5. Профілактика та пропаганда здорового способу життя:		
	Обмеження контактів і спільного використання предметів побуту з людьми Дотримуватися правил індивідуального використання засобів гігієни та косметики,регулярне миття рук	Сказати/записати в історію хвороби